

NOTULEN

HARI / TANGGAL : Selasa / 05 Mei 2026
 PUKUL : 07.45 – 16.45 WIB
 AGENDA RAPAT : Survei Simulasi Akreditasi – Daring
 (Manajemen)

PEMIMPIN RAPAT : Direktur Rumah Sakit
 NOTULIS : Nur Rizkiah Amalia
 TEMPAT : Hybrid (Hall Sakura)

Berikut hasil notulen :

NO	POKOK BAHASAN	MASALAH	TINDAK LANJUT	PIC
1.	Presentasi Direktur	Tanggapan dr. Ari Putriani, Sp.PK 1) Proses pemilihan IMPRS dinilai belum terpaparkan secara jelas. 2) Pemilihan Clinical Pathway (CP) perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi di rumah sakit berdasarkan data dari unit casemix, khususnya pada kasus gangrene dengan kode ICD-10. Selain itu, strategi dan pendekatan yang telah dilakukan oleh manajemen perlu dijelaskan secara lebih detail. 3) Implementasi <i>guest culture</i> serta peningkatan pelaporan IKP perlu dipaparkan lebih rinci.	1) Dijelaskan kembali proses pemilihan IMPRS. 2) Dilakukan perbaikan pada CP dan PPK dengan penyesuaian menggunakan bahasa/kode ICD. 3) Informasi dari unit disampaikan melalui briefing direktur kepada masing-masing unit. Hasil pelaporan dari kepala bidang dan unit dinilai sudah cukup baik. Strategi yang diterapkan adalah komunikasi aktif melalui briefing rutin setiap pagi antara direktur dan kepala bidang. Dampak dari pelaporan IKP diterapkan dengan prinsip keadilan, sehingga tidak langsung diberikan hukuman secara serta-merta. Setiap kesalahan tetap diberikan sanksi yang adil dan proporsional agar dapat menjadi pembelajaran	Direksi



				bersama serta mendorong perbaikan berkelanjutan.	
	2.	Presentasi direktur (dokter Aslikah)	Tanggapan dr. Aslichah 1) Waktu presentasi melebihi ketentuan yang telah diberikan, yaitu lebih dari 7 menit dari total waktu 40 menit. 2) Perbaikan sekunder pada tahun 2025 belum tampak secara jelas. 3) Proses pemilihan IMP-RS, khususnya terkait diagnosis yang menjadi permasalahan berdasarkan 9 kriteria, perlu ditampilkan secara lebih jelas (Poin A). 4) Perlu dijelaskan keterkaitan antara FMEA dengan hasil budaya keselamatan rumah sakit, khususnya pada aspek komunikasi yang mencapai 98%, namun belum selaras dengan rendahnya pelaporan dan respons yang diberikan.	1) Melakukan review terhadap materi presentasi agar pelaksanaan presentasi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan 2) Poin tersebut ditambahkan dalam materi presentasi direktur. 3) Menyusun rekomendasi implementasi sebagai tindak lanjut perbaikan. 4) Pada FMEA terkait <i>main risk</i>, perlu ditambahkan kolom “residu yang diharapkan” sebagai target perbaikan dari kategori merah menjadi kuning. Target perbaikan ditetapkan dalam kurun waktu 3 bulan, kemudian dilakukan evaluasi berkala setiap 3 atau 6 bulan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan program <i>main risk</i> sehingga target residu yang diharapkan dapat tercapai melalui program perbaikan yang terukur dan berkelanjutan.	Direksi
	3.	Wawancara pemimpin RS	dr. Ari Putriani, Sp.PK Direktur 1) Bagaimana manajemen penanganan komplain dan bagaimana hasil implementasinya? Harapannya, rumah sakit memiliki sistem penanganan komplain yang terintegrasi,	1) Peran PIPP dalam pengelolaan komplain dilakukan melalui penggunaan <i>Google Spreadsheet</i> sebagai media pencatatan dan monitoring komplain. Seluruh sumber komplain dicatat beserta tindak lanjut penanganannya.	Direksi



		baik dari pengaduan langsung maupun melalui <i>Google Review</i>. Penjelasan yang disampaikan diharapkan lebih sistematis, termasuk alur penanganan komplain serta mekanisme rapat tindak lanjut terkait penanganan komplain, sehingga jawaban yang diberikan seragam dan sesuai dengan manajemen rumah sakit. 2) Apakah terdapat benchmarking dengan rumah sakit lain, serta bagaimana upaya perlindungan dan pengamanan data yang diterapkan? 3) Apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam penerapan <i>patient safety</i> di rumah sakit?	Direktur turut memantau proses penyelesaian dan memberikan arahan apabila terdapat komplain yang belum terselesaikan. Selain itu, komplain juga dapat berasal dari pihak PT maupun pihak eksternal lainnya. Salah satu contoh komplain berasal dari perangkat desa. Komplain tersebut ditindaklanjuti melalui diskusi dan penanganan langsung pada hari yang sama. Seluruh proses penanganan dicatat, termasuk poin-poin yang perlu diperbaiki, sehingga terdapat hasil evaluasi dan tindak lanjut perbaikan yang jelas. 2) — 3) Kecepatan pelayanan di IGD masih menjadi fokus perbaikan, dengan tantangan utama memastikan bahwa pelayanan cepat tetap sesuai dengan aturan dan SOP yang berlaku. - Kepala Bidang Pelayanan, fokus perbaikan diarahkan pada unit layanan IGD, khususnya terkait percepatan pelayanan dari sisi DPJP, administrasi, dan SDM. Selain itu, proses transfer pasien dari IGD ke rawat inap diupayakan	
--	--	--	--	--



				dapat dilakukan maksimal dalam waktu 1 jam, dengan mempertimbangkan kondisi pasien dan kesiapan ruang perawatan.	
4.	Wawancara pemimpin RS	dr. Aslichah : 1) Bagaimana evaluasi penerapan visi dan misi dikaitkan dengan mutu pelayanan yang diterapkan dari waktu ke waktu? 2) Bagaimana proses penilaian kinerja mutu dan IKP dilakukan di rumah sakit? 3) Apakah terdapat pengkajian secara berkelanjutan terhadap hasil budaya keselamatan serta tren penurunan IKP? 4) Bagaimana upaya SDM dalam melakukan perbaikan berdasarkan hasil survei budaya keselamatan, pengkajian IKP, dan <i>main risk</i> , sehingga dapat meningkatkan pengetahuan maupun kinerja SDM secara berkelanjutan?	1) Evaluasi penerapan visi, misi, mutu, dan IKP dilakukan setiap bulan oleh manajemen rumah sakit. Hasil evaluasi meliputi capaian mutu, target, IKP, serta permasalahan yang terjadi di rumah sakit dan dipertanggungjawabkan kepada pihak PT melalui laporan direktur. Selain itu, PT juga melakukan pertemuan rutin (<i>laporan bulanan/Lapbul</i>), supervisi kepala bidang, serta pertemuan antara direktur dan kepala bidang. Beberapa indikator, seperti INM, masih belum mencapai target yang ditetapkan. 2) Penilaian kinerja mutu dan IKP dilakukan setiap bulan secara berjenjang, mulai dari kepala ruangan kepada unit di bawahnya. Dalam proses tersebut terdapat penilaian terhadap poin mutu pada masing-masing unit. 3) Pengkajian terhadap budaya keselamatan dan IKP dilakukan	Direksi	



				secara berkelanjutan. Setiap IKP yang dilaporkan akan ditindaklanjuti oleh kepala bidang hingga direktur. Khusus untuk IKP murni, kasus sentinel, dan KPD dilakukan audit sebagai bentuk evaluasi dan perbaikan layanan. 4) Upaya peningkatan SDM dilakukan melalui usulan kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang terjadwal terkait budaya keselamatan, <i>main risk</i>, serta pengkajian IKP. Diharapkan kegiatan tersebut dapat meningkatkan pengetahuan, kepatuhan, dan kinerja SDM secara berkelanjutan.	
5.	TKRS	1) TKRS 1 EP C => Evlauasi kinerja Pemilik adalah komisaris, Direktur PT dinilai oleh komisaris-> Belum terlampir 2) TKRS 2 EP B=>Poin A-B => Bukti RS menjalankan Operasional Rumah sakit 3) SK pelayanan => Ditampilkan terkait dengan layanan yang bisa dan yang tidak bisa dilakukan di RS Prima Husada 4) TKRS 4D => 5) TKRS 6 EP A = 6) TKRS 6 EP B 7) TKRS 6 EP C 8) TKRS 6 EP D 9) TKRS 6 EP F 10) TKRS 10 EP A 11) TKRS 10 EP B	1) Dilakukan follow up ke PT terkait penilaian Direktur oleh Komisaris PT. 2) Dokumen yang harus disiapkan meliputi Renstra, RBA tahun 2026, Clinical Pathway (CP), kebijakan hak dan kewajiban pasien, penilaian etik profesi, laporan mutu dan manajemen risiko, bukti laporan bulanan RS kepada PT, serta kebijakan fraud. 3) SK pelayanan dipresentasikan oleh Direktur dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan menggunakan format	PJ TKRS	



		12) TKRS 10 EP C 13) TKRS 10 EP D=> Bukti IMP baru adalah penggantian dari IMP yang lama yang sudah tercapai 14) TKRS 11 C 15) TKRS 12 16) TKRS 13 EP A 17) TKRS 13 EP B 18) TKRS 13 EP C 19) TKRS 13 EP D 20) TKRS 13 EP E 21) TKRS 14 EP A 22) TKRS 14 EP D	tabel pada saat paparan direktur. 4) Dalam rapat koordinasi, Umandok perlu dilengkapi dengan dokumen pemilihan indikator mutu prioritas rumah sakit beserta persentasenya. 5) Regulasi yang mengakomodasi kontrak perlu mencantumkan HBL. Untuk MOU perlu ditambahkan indikator mutu kontrak seperti ketepatan waktu dan QC yang berjalan dengan baik. 6) Kredensial KTKL dan Komite Keperawatan perlu diperbarui sesuai regulasi Undang-Undang yang terbaru, termasuk penyesuaian pada SPK. 7) Dilakukan evaluasi PKS dengan pihak ketiga, salah satunya dengan Rentokil. 8) Setiap lampiran kontrak harus disajikan secara utuh, dan isi MOU baru dapat di-<i>highlight</i> terutama pada bagian jangka waktu, tanpa memotong dokumen. 9) Perlu dilengkapi rekomendasi dari tenaga ahli, seperti perhimpunan Radiologi, uji	
--	--	---	--	--



				fungsi, serta penggunaan sistem IT dalam implementasi sistem. 10) Setiap bukti yang dilampirkan harus diberi judul yang jelas, seperti indikator mutu unit farmasi, identifikasi pasien, dan <i>hand hygiene</i>. 11) Data yang ditampilkan harus konsisten antara INM dan IMPRS, tidak boleh terdapat perbedaan, serta harus sesuai rekap PIC. 12) IMP unit yang ditampilkan cukup 1 indikator per unit, tidak perlu seluruhnya. Ditampilkan maksimal 5 unit seperti Laboratorium, Radiologi, dan IKO. 13) Contoh yang dilampirkan dapat berupa IMP unit Laboratorium tahun 2025, misalnya angka phlebotomi yang menunjukkan hasil baik sehingga menjadi dasar target tahun 2026. 14) OPPE untuk perawat dan tenaga medis dimasukkan dalam penilaian kinerja, termasuk aspek mutu seperti identifikasi pasien dan lainnya. 15) Komite etik bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pelaporan kegiatan.	
--	--	--	--	--	--



				16) Panduan budaya keselamatan kerja perlu direvisi dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 17) Seluruh staf diberikan akses terhadap kepustakaan sebagai sumber referensi. 18) Budaya keselamatan tidak hanya mencakup IKP, tetapi juga aspek lainnya. 19) Umandok perlu mencakup sosialisasi alur penggunaan SIMRS, khususnya untuk pelaporan insiden. 20) Perlu disiapkan bukti tindak lanjut apabila terjadi kejadian tidak diinginkan, misalnya mutasi karyawan (contoh staf dipindahkan ke unit laundry). 21) Yang dilampirkan adalah Program Manajemen Risiko yang telah ditandatangani oleh Direktur. 22) Umandok rapat penyusunan risk register perlu menghasilkan dokumen akhir berupa Risk Register.	
6.	PMKP	1) Program PKMP dan Program komite PMKP 2) PMKP 1 EP D = > saat rapat dihadiri komite Komite medis, komite keperawatan, komite PPI	1) Program PMKP ditampilkan secara lengkap dalam paparan. 2) Bukti absensi perlu mencantumkan kehadiran komite medik, komite	PJ PMKP	



		3) PMKP 2 EP B 4) PMKP 3 5) PMKP 4 EP A 6) PMKP 4 EP B 7) PMKP 4 EP C 8) PMKP 4 EP D 9) PMKP 4 EP G 10) PMKP 5 EP A 11) PMKP 6 EP C 12) PMKP 7 EP A 13) PMKP 8 EP C 14) PMKP 11 C	keperawatan, dan PPI (ditambahkan). 3) Judul laporan direvisi dan dilengkapi dengan kesimpulan secara umum (tidak per kasus), kemudian diikuti dengan tindak lanjut. 4) Bukti INM 5 diberi judul yang jelas sesuai tampilan yang ada, serta dikorelasikan dengan TKRS. 5) Proses analisis dijelaskan menggunakan metode statistik. 6) Laporan rekomendasi perbaikan perlu dituangkan dalam bentuk nota dinas atau disposisi Direktur. Efisiensi sekunder SDM dan dana perlu dianalisis dengan membandingkan tarif RS sebelum dan sesudah implementasi CP, dengan tujuan menunjukkan adanya efisiensi. Selain itu, efisiensi primer juga dilihat dari tingkat kepuasan pasien. 7) Ditambahkan <i>best practice</i> sebagai bagian dari laporan. 8) Dilakukan proses kajian terlebih dahulu, tidak hanya langsung membandingkan data. 9) Penjelasan tetap mengacu pada poin 6 terkait efisiensi dan evaluasi CP. 10) Data mentah hasil validasi disusun menjadi laporan, termasuk materi terkait validator, sehingga pada	
--	--	---	--	--



			tahun 2026 dapat dibuat laporan yang lebih komprehensif. 11) IMPRS klinis dipilih sebanyak 5 CP yang relevan. Jika IMPRS berkaitan dengan diabetes, maka dibuat CP dan PPK untuk DM (misalnya DM hiperglikemia, DM hipoglikemia, dan DM dengan tindakan debridement). Tujuannya agar CP menjadi bukti kendali mutu sekaligus kendali biaya. 12) Diperlukan bukti RCA untuk kejadian sentinel atau kejadian grading kuning, dilengkapi dengan kronologi serta analisis <i>fishbone</i>. 13) Pelaporan transfusi yang telah dikonfirmasi masih belum tersedia, demikian juga pelaporan reaksi obat. Kasus sentinel tidak perlu dimasukkan dalam kategori ini. 14) Profil risiko diunggah dan diperdalam dalam paparan direktur, serta harus mampu menjelaskan dasar pemilihan profil risiko yang digunakan.	
7	KPS	1. KPS 1 EP 2 2. KPS 1 EP 3 3. KPS 4 Untuk Medis 4. KPS 8 EP 1 5. KPS 9 EP 2 6. KPS 9 EP 5 7. KPS 10 s/d 13	1) Regulasi ketenagaan perlu mengacu pada peraturan yang berlaku. Perhitungan kebutuhan perawat menggunakan standar Depkes, sedangkan tenaga penunjang menggunakan analisis beban kerja (perlu dicek kembali).	PJ KPS



				2) Dalam perencanaan kebutuhan staf perlu ditambahkan kualifikasi pendidikan, contoh: Direktur minimal S2 Nakes. 3) OPPE klinis harus mencakup indikator mutu rumah sakit yang relevan dengan individu, meliputi: - Perilaku (misalnya keterlambatan praktik dokter, keterlambatan visite) - Profesionalisme dan kinerja klinis (misalnya kepatuhan identifikasi pasien) Untuk non-klinis menggunakan logbook harian/bulanan dari karu atau kbid sesuai RKK, mencakup kedisiplinan, komunikasi, dan profesionalisme. Penilaian didasarkan pada evaluasi kbid dan audit. File kepegawaian harus lengkap (SPK, RKK, ijazah, SIP) dan disimpan dalam folder SIMRS, serta perlu disosialisasikan ke unit. 4) Simulasi BHD perlu diaktifkan kembali. Untuk BHD tingkat lanjut wajib pada unit IGD, IKO, dan ICU dengan verifikasi sertifikat.	
--	--	--	--	---	--



				5) Program K3 mencakup MCU, penanganan pajanan (misalnya tertusuk jarum), serta penanganan staf yang terinfeksi penyakit (misalnya TBC atau campak). Program ESQ juga diperlukan untuk pengelolaan kesehatan mental staf. Kasus infeksi pada staf (misalnya ISPA, influenza, TBC) dilaporkan ke PPI. Kejadian nihil seperti kekerasan tetap dilaporkan dalam bentuk tabel bulanan. 6) Komite terkait kredensial dokter dengan kompetensi tambahan (fellow) perlu diperjelas. Untuk tenaga keperawatan, dilakukan penilaian persentase PK 0–4 yang dievaluasi setiap 3 tahun sekali.	
8.	MFK (File dokumen dirapikan)	1) MFK 1 2) MFK 2 EP C 3) MFK 2 EP D 4) MFK 5 5) MFK 3 EP 4 6) MFK 3 7) MFK 4 8) MFK 6 EP 2 9) MFK 7 EP 1 10) MFK 8 EP 1 11) MFK 8 EP 2 12) MFK 8 EP 3 13) MFK 9 14) MFK 10	1) Perlu penyesuaian dengan undang-undang yang berlaku serta pemahaman perbedaan aspek keselamatan dan keamanan. a. APAR dan spill kit harus dilabelisasi (tidak dalam bentuk soft file). b. Cadangan air dan listrik dilakukan pemeliharaan serta uji fungsi. c. Pelatihan <i>disaster</i> wajib dibuktikan. d. IGRA menggunakan PCRA dan mitigasi risiko.	PJ MFK	



			15) MFK 11	e. Pelatihan terkait dimasukkan dalam paparan Direktur. f. Perizinan dimasukkan dalam paparan Direktur. g. RBA yang terkait MFK diberi penanda khusus. 2) Laporan supervisi <i>rounding</i> fasilitas dibuat dalam bentuk checklist dan dilakukan 1 bulan sekali, mencakup aspek keselamatan dan keamanan secara item per item. 3) Tidak diperbolehkan adanya penyewaan tenant atau kerja sama dengan pihak ketiga (TDD). 4) Surat pemberitahuan direvisi agar lebih detail, mencakup aspek keamanan dan keselamatan. 5) Laporan mutu PMKP dilampirkan setiap 6 bulan. 6) Area penyimpanan B3 perlu dilakukan sosialisasi terkait pertanyaan dan penanganannya. 7) Dalam MOU perlu diatur waktu pemutusan kerja sama agar tidak mengganggu pelayanan, serta indikator mutu seperti ketepatan pengambilan dan transporter dimasukkan dalam hak dan kewajiban (di-<i>highlight</i>). 8) Tanda jalur evakuasi harus ditempatkan pada ketinggian 40–50	
--	--	--	------------	--	--



				cm dari lantai atau setinggi pandangan manusia di luar gedung agar mudah terlihat. - Pemeliharaan hydrant dan uji fungsi dilaporkan dalam UMANDOK atau laporan bulanan (belum masuk G-Drive). - Uji fungsi disertai jadwal pelatihan dan TOR. - <i>Debriefing</i> belum dilakukan. 9) Pemeliharaan dilakukan harian oleh unit dan bulanan oleh IPSRS. - Pelaporan recall alat hematologi KSO perlu dicantumkan. - Setiap alat baru wajib uji fungsi, pelatihan operasional, dan sertifikat kompetensi dari vendor, terutama alat kritikal (warna oranye–merah), atau dilakukan <i>refreshing</i> pelatihan. 10) Seluruh supervisi menggunakan checklist yang dilengkapi kolom temuan. - SPO keputusan MCB perlu disosialisasikan, termasuk fungsi tuas MCB di setiap gedung. - Inventarisasi komponen kritikal (listrik, genset, air, gas medis, dll) harus dibuat dan diperiksa secara rutin.	
--	--	--	--	---	--



				11) Perlu dijelaskan perhitungan kebutuhan sumber air rumah sakit per orang per hari. 12) Pemeriksaan air bersih dilakukan 1 tahun sekali, sedangkan air limbah setiap 3 bulan sekali sesuai regulasi/kebijakan rumah sakit, dengan bukti pemeriksaan yang lengkap. 13) Identifikasi risiko bencana perlu disesuaikan, dengan prioritas utama kebakaran dan gempa bumi. 14) Pada ICRA/RCA, dokumentasi wajib mencakup kondisi sebelum, selama, dan sesudah renovasi, termasuk foto petugas menggunakan APD untuk pencegahan debu. 15) Absensi dalam UMANDOK wajib menggunakan tanda tangan asli, tidak diperkenankan menggunakan ketikan.	
9.	PPI	1. PPI 1 EP C 2. PPI 3 EP 2 3. PPI 4 4. PPI 4.1 5. PPI 6 EP B 6. PPI 7.1 7. PPI 7.2 8. PPI 9 9. PPI 10 10. PPI 11	1) Masukkan UMANDOK triwulan 1 tahun 2026 ke G-Drive 2) Penanganan IDO dilaksanakan sesuai standar. Usulkan pelatihan penyuntikan dasar, disebutkan bahwa masuk dalam pelatihan PPI dasar. 3) Form supervisi dibuat menurun, jangan mendatar. Dilihat kapan	PJ PPI	



		11. PPI 13	terakhir kali kalibrasi. Jangan lupa sterilisasi pakai FIFO. 4) Di SK Pelayanan dituliskan bahwa tidak ada single use yang di re-use. Ketika pelaksanaan ada IPCLN ada yang stand-by. 5) Diberi panah untuk alur linen. Infeksius dan non infeksius dipisahkan. Tampilkan troli linen kotor yang baru. 6) Masukkan mutu dan waktu (berapa lama pelaksanaan agar tidak mengganggu pelayanan) di MoU. 7) Tambahkan alur transit jenazah 8) Tambahkan bukti dokumentasi keset basah (PCRA IKO) 9) Dipasang magnahelic di ruang isolasi immunocompromised. 10) Pastikan lagi terkait hand hygiene sesuai standar kepada semua staf. 11) Tambahkan absensi sampai sertifikat pelatihan dasar PPI pada orientasi staf baru.	
10.	MRMIK	1) MR MIK 1 EP B 2) MR MIK 1 EP D 3) MR MIK 2.1 EP A 4) MR MIK 2.1 EP C 5) MR MIK 2.2 EP A 6) MRMIK 2.2 EP C 7) MRMIK 3 EP C 8) MRMIK 5 EP C 9) MRMIK 5 EP D	1) Untuk SIMRS, tambahkan bisa diakses pimpinan 2) Eksternal -> sosialisasi bridging dengan satu sehat (Ada di Bab RM) 3) Hak akses diberikan narasi, jadikan word, screenshot tampilan awal login simrs	PJ MRMIK



		10) MRMIK 7 EP B 11) MRMIK 8 EP C 12) MRMIK 9 13) MRMIK 10 dan MRMIK 12 EP C 14) MRMIK 13 15) MRMIK 13 EP 1	4) Supervisi akses, tambahkan analisis, dicek apakah ada yang melanggar peraturan 5) Tambahkan stempel/tulisan “dilarang masuk” di ruang rekam medis 6) Monev untuk penambahan storage 7) MOU dimasukkan untuk indikator mutu kontrak dan waktu pengakhiran Kerjasama (agar ada tenggat waktu) Highlight 8) Disiapkan dokumen untuk telusur 9) Untuk Supervisi dari internal apabila Audit yang melakuakn Audit dilakukan oleh IT -> harusnya dengan SPI atau yang lain 10) Prosedur koreksi belum dilampirkan dengan ERM (ketentuan yang boleh dikoreksi dan berapa lama boleh dikoreksi) 11) Contoh hasil evaluasi dari yang tidak sesuai dengan Singkatan / kode ICD 12) SK tim review RM (untuk undang – undang diperbarui yang sudah tdak berlaku tidak perlu dicantumkan) - Ketua tim review harus memahami pertauran terkait dengan rekam medis - Ketepatan waktu pengisian Rekam medis dimasukkan laporan review rekam medis	
--	--	--	--	--



			13) Pedoman Pengorganisasian dicek lagi undang – undang, Direktur yang sekarang TTD - Dimasukkan untuk SPK dan RKK TIM IT - TTD pada SK dan SPO sesuaikan dengan SK direktur yang berlaku 14) SPO Downtime dibuat untuk user yang dilapangan (belum ada)	
11.	PROGNAS	1. HIV 1) PROGNAS 3 EP 1 2) PROGNAS 3 EP 3 3) PROGNAS 3 EP 4 4) PROGNAS 3 EP 6	1) Penambahan pada poin program kerja HIV (penunjang) 2) Alur pasien yang datang tidak pernah melakukan ANC maka langsung dilakukan screening 3) Pada Laporan tahunan HIV -> dicek kan lagi untuk pasien dengan IO yang masuk dari IGD (Pneumonia) -> daftar pasien yang dirujuk dari prima husada 4) Aplikasi SIHA (Screenshoot)	PJ HIV
		2. PONEK 1) PROGNAS 1 EP 1 2) PROGNAS 1 EP 4 3) PROGNAS 1 EP 5 4) PROGNAS 1.1. EP 1 5) PROGNAS 1.1 EP 3	1) Pelatihan Nasional untuk TIM PONEK - Menambahkan Regulasi untuk PEDOMAN PELAYANAN PONEK 2) Pada pelaporan PONEK dimasukkan SHK dalam Unit maternitas - Pada IMD kolomnya di tambahkan kolom Prosentase (untuk melihat tidak tercapai	PJ PONEK



				100%) dan dilakukan Analisa penyebabnya - PNC Perhitungannya =i total kelahiran / PNC = Capaian (direvisi menggunakan prosentase) -> dilakukan Analisa 3) Monev => Formatnya direvisi=> contohnya menggunakan PPI Menggunakan Ceklist (Sesuai tata naskah) 4) Dilampirkan Program dan buktinya 5) Direvisi lagi konten dari Pelaksanaan Jejaring rujukan (bahasanya diperbaiki)	
			3. TB DOT'S 1) PROGNAS 2 EP.3 2) PROGNAS 2 EP 1 3) PROGNAS 2.2 4) PROGNAS EP 2.2 5) TB MDR	1) Laporan Program (dilaksanakan Riil Time) dan Bukti Umandok pelaksanaan formatnya beda (saat pelatihan apa) -> koordinasi dengan KE 2) Digambarkan untuk denah aliran FLOW untuk Ruang poli TB (harapannya Dokter dan perawat tidak terkena TB) dan Ruang RAWAT INAP ISOLASI -> Koordinasi dengan PPI 3) Bukti penerapan PPK TB terhadap pada pelayanan pasien TB-> dibuat lapor kepatuhan PPK TB 4) Penambahan Pada program kerja: adanya penyediaan Obat TB / OAT	PJ TB DOT'S



			(mulai dari Usulan sampai Pelaksanaan) -> Rencana pengadaan (ditambahkan tampilan SITB) 5) Ditambahkan MOU dengan jejaring -> Dengan RS. UMM (sesuai dengan standar MOU)	
		4. STUNTING & WASTING	Cek undang – undang disetiap Regulasi Pedoman , SK dl	PJ STUNTING & WASTING
		5. KBRS 1) PROGNAS 5.1 EP 1 2) PROGNAS 5.1 EP 2	1) Didalam Pedoman Dilengkapi semua SPO (SPO edukasi individu (pasien post curettage) dan kelompok) 2) Pelaksanaan SPO Edukasi individu Cek terkait dengan undang-undang yang mash berlaku dan terbaru dan berkaitan	PJ KBRS
		6. PPRA 1) Program PPRA no 4.2 2) PROGNAS 6 EP D 3) PROGNAS 6.1 EP A 4) PROGNAS 6.1 EP B 5) PROGNAS 6.1 EP C	Koordinasi dengan dr. Ari G-DRIVE (untuk bentuk pelaporan) 1) Contoh kasusnya: Forkit terintegrasi contoh Persepan antibiotic kasus bedah dengan penyakit dalam -> kasusnya dokter anton -? Anamnesa awal, Riwayat penyakit, Riwayat obat -> dilakukan konsul atau raber 2) Revisi FORM Supervisi PPRA menggunakan CEklist-> Kolom ke samping terlaksan, tidak terlaksana dilakukan per bulan -> contoh laporan PHS	PJ PPRA



			3) Penyamaan persepsi dengan DPJP dan Apoteker saat dilakukan wawancara	
--	--	--	---	--

Surveior Manajemen

dr. Ari Putriani, Sp. PK

Malang, 05 Mei 2026

Notulis

Nur Rizkiah Amalia

Mengetahui,
Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Resti Lestantini, M. Kes

DOKUMENTASI

